EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 90551
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 13-08-2024

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: RENE ENRIQUE GARRIDO VILLALOBOS			RUN	: 5.779.929-3
F.Nac	: 12-02-1946	Edad	: 78 AÑOS, 6 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: ZEMITA FONO ACT			Comuna	: NIQUEN
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 70709346		
Fecha Ingreso	: 2024-08-07	Fecha Egreso	: 13-08-2024	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I50.9-INSUFICIENCIA CARDIACA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1-EPOC GOLD E EXACERBADO CON SOBREINFECCION?
2-ICC FEVI A PRECISAR
3-OBS IAM TIPO 2
4-FA CRONICA
5-HTA SISTEMICA
6-DM2IR DESCOMPENSADA
7-ERC ETAPA IV
8-HPB
9-OBESIDAD
10- ITU E. Coli Blee

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I50-INSUFICIENCIA CARDIACA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

PACIENTE MASCULINO CON ANTECEDENTES DE HTA SISTEMICA, DMIR, EPOC GOLD E USUARIO O2 DIURNO Y VMNI NOCTURNO, ICC, ERC ETAPA IV CON HOSPITALIZACION RECIENTE 07/24 EN CONTEXTO DE ICC DESCOMPENSADA QUIEN FAMILIAR REFIERE INICIO DE CUADRO CLINICO HACE 1 SEMANA APROXIMADAMENTE AL PRESENTAR AUMENTO DEL PATRON DE DISNEA HABITUAL ASOCIADO A TOS SECA QUE POSTERIORMENTE SE HACE PRODUCTIVA , FATIGA, HIPOREXIA Y COMPROMISO DEL ESTADO GENERAL, SIENDO LLEVADO AL CAE
PROGRAMADO POST ALTA DONDE OBJETIVAN CIFRAS GLICEMIA 45MG/DL POR LO QUE DERIVAN AL SU HSC DONDE INGRESA PACIENTE CON REQUERIMIENTOS DE
FIO2, CON SINTOMAS DE CONGESTION PULMONAR Y SOSPECHA DE SOBREINFECCION BACTERIANA POR LO CUAL SE PANCULTIVA Y SE INICIA TERAPIA EMPIRICA CON CEFTRIAXONA Y AZITROMICINA DURANTE 5 DIAS LUEGO SE RESCATA OC + UROC CON E. COLI BLEE POR LO CUAL SE AJUSTA ABT POR CULTIVO CON ERTAPENEM HOY COMPLETA 4 DIAS DEBIDO A BUENA EVOLCUION SE DECIDE ALTA CON HODOM PARA COMPLETAR TRATAMIENTO.

PLAN DE MANEJO:

COMPLETAR ESQUEMA ANTIBIOTICO EN HODOM
LAB CONTROL MAÑANA TP, INR
OC + UROC CONTROL AL CULMINAR TTO MEDICO
ECOCARDIOGRAMA PENDIENTE
CONTROL EN 1 SEMANA POSTERIOR A ALTA DE HODOM EN POLI MEDICINA DRA RIVAS
CONTROL EN POLI TACO
CONTROL EN POLI DE BRONCOPULMONAR

INDICACIONES AL ALTA

1. REPOSO RELATIVO
2. RESTRICCIÓN HIDRICA 1000CC/DIA
3. MANTENER O2 DIURNO CON VMNI NOCTURNO (DEBE SER TRAIDO POR FAMILIARES)
4. REGIMEN LIVIANO PARA DIABETICOS
5. PENDIENTE ECOCARDIOGRAMA
6. NBZ CON BERODUAL 2:2 CADA 6 HORAS
7. SALMETEROL FLUTICASONA 2 PUFF C/12H
8. B.IPRATROPIO 4 PUFF CADA 4HRS
9. INSULINA NPH 8 UNDS SC AM Y 4 UNDS SC PM
10. IC SEGUN HGT
11. TRELEGY 2 PUFF C/24H
12. KNT RESP X 2
13. Acenocumarol 1/2 comprimido día
14. Tamsulosina 0.4mgrs vo día
15. LAB CONTROL INR
16. OMEPRAZOL COMPRIMIDO 20 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
17. AMIODARONA COMPRIMIDO 200 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
18. BISOPROLOL COMPRIMIDO 2,5 MILIGRAMOS 2 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
19. FUROSEMIDA COMPRIMIDO 40 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
20. EMPAGLIFLOZINA 10MG COMPRIMIDO UNIDAD 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
21. ATORVASTATINA COMPRIMIDO 40 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
22. BROMURO DE IPATROPIO P/NEBULIZAR FRASCO 0,025% 4 puff cada 4hrs
23. FLUTICASONA/SALMETEROL INHALADOR 250 MICROGRAMOS / 25 MICROGRAMOS 2 puff cada 12hrs
24. ERTAPENEM 1 GR. AMPOLLA UNIDAD 0.5 ampolla cada 24 hrs. por 3 dias via ENDOVENOSA
25. ACENOCUMAROL COMPRIMIDO 4 MILIGRAMOS 0.5 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL- AJUSTAR SEGUN INR EN POLITACO

EXÁMENES Y RESULTADOS

CSB NEGATIVO
UROCULTIVO + E. COLI BLEE
PANEL VIRAL NEGATIVO
Creat 2.30 glic 176 PCR 28.9 ELP 140/.0/99 NT pro BNP 2814
ph 7.49 pco2 44 po2 60 hco3 33.7 sato2 87%

Claudia Paola Rivas Pacheco
MEDICO TRATANTE
27781954-6

JEFE SERVICIO